

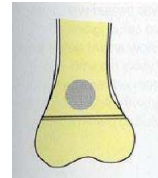
- ✓ Infection médullaire primitive par voie hématogène +++
- ✓ Germe : **staphylocoque doré** (suite à une plaie +++)
- ✓ Touche surtout : l'enfant +++ 6 à 12 ans, garçons
- ✓ Plus fréquente chez les **drépanocytaires**
- ✓ **Près du genou, loin du coude +++++**
- ✓ **Métaphysaire (richement vascularisée) = extra-articulaire**
- ✓ **Très fréquente en Algérie et au Maghreb, urgence thérapeutique !**

03 PHASES :

1. **Phase congestive** : Fixation et multiplication du germe au niveau de la métaphyse → Inflammation et œdème
2. **Abcès sous-périosté** : Inflammation du périoste → Abcès sous-périosté
3. **Nécrose** : Interruption de la vasc centro-médullaire et périostée → **Os mort avasculaire (séquestre osseux)**

CLINIQUE :

- ✓ **Syndrome infectieux** : frissons, fièvre, sudation, AEG
- ✓ **Douleur : métaphysaire extra-articulaire**, brutale
- ✓ **Impotence fonctionnelle**
- ✓ **Tuméfaction fluctuante + douleurs plusatiles = collection (abcès sous-périosté)**
- ✓ **Pas d'adénopathies +++++**



LOCALISATION :

- **Enfant** : **Genou+++** hanche, épaule (près du genou loin du coude)
- **Adulte** : Fémur, rachis, pied

Examens en urgence :

- **FNS** : hyperleucocytose à PNN + **Hémoculture**
- **CRP** : **positivation précoce** VS : **augmentation tardive, normalisation lente +++++**
- **Radio** : **signes retardés par rapport à la clinique**
 - ✓ Œdème des parties molles
 - ✓ Apposition périostée (réaction du périoste vis-à-vis d'une agression locale)
 - ✓ Déminéralisation diffuse
 - ✓ **Séquestration osseuse**
- **Echographie** : **abcès sous-périostés**

Autres examens :

- **Scanner** : pour les localisations vertébrales
- **Scintigraphie** : **hyperfixation précoce**
- **Ponction métaphysaire**

FORMES CLINIQUES :

1. **Ostéomyélite subaiguë** : début insidieux, symptomatologie fruste et bilan bio peu perturbé, bénigne
2. **Ostéomyélite chronique** : fractures pathologiques avec pseudarthrose, Séquestre osseux, Suppuration chronique : Fistules cutanées, amyotrophie
3. **Abcès de BRODIE** : Lacune purement intra-osseuse bordée par une zone de **sclérose osseuse de siège métaphysaire ou métaphyso-épiphysaire**



TRAITEMENT :

- 1) **Antibiothérapie** :
 - * **< 03 ans** : Céfotaxime + Fosfomycine **> 03 ans** : Oxacilline + Gentamycine
 - * **Durée** : 06 semaines : IV pendant 02 semaines, relais per os
- 2) **Plâtre** : **pendant 45 jours** (de protection et antalgique)
- 3) **Drainage (pas une ponction)** : en cas de collection
- 4) **Ostéomyélite chronique** : ablation du séquestre osseux et soins de la fistule

En l'absence de traitement, elle évolue vers la chronicité +++++

Fich Flach

- ♥ Douleur **métaphysaire** circulaire (extra-articulaire) : évocatrice
- ♥ Localisation la plus fréquente chez l'enfant : Genou
- ♥ CC Résidanat : même après trauma, chez l'enfant : **impotence + Dlr métaphysaire+ fièvre = OMA++++**
- ♥ Tuméfaction fluctuante rouge chaude : stade de collection → drainage chir
- ♥ Trt : ATB + plâtre d'emblé (et non pas que si fracture associée)
- ♥ Peut se compliquer d'arthrite purulente
- ♥ Séquestre osseux : fragment d'os mort qui baigne dans le pus
- ♥ Abscess sous-périosté : diagnostiqué simplement par échographie
- ♥ Antalgiques : paracétamol 60mg/kg/jr, **les AINS ne sont pas indiqués++++**